

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

STAI · CUESTIONARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO

State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger) – Patrón de referencia psicométrico internacional para la discriminación entre ansiedad transitoria (A/E) y predisposición ansiosa constitucional (A/R)

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	State-Trait Anxiety Inventory (STAI - Forma X / Forma Y)
Nombre en español	Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo
Sigla oficial	STAI
Autores originales	Charles D. Spielberger, Richard L. Gorsuch y Robert E. Lushene (1970, 1983)
Adaptación hispanohablante	Nicolás Seisdedos Cubero (TEA Ediciones, 1982, 2002); G. Buela-Casal et al. (2011)
Año de publicación original	1970 (edición española TEA en 1982; revisión y baremos actualizados en 2011)
Constructo primario	Doble constructo: Ansiedad como estado emocional transitorio (A/E) y como rasgo latente de personalidad (A/R)
Formato de administración	Autoinforme estructurado con 2 subescalas independientes de 20 ítems en escala Likert de 4 puntos
Población diana	Adolescentes y adultos (≥ 14 años) evaluados en contextos clínicos, laborales o de investigación
Tiempo de aplicación	12 a 18 minutos (40 ítems en total; aprox. 7 minutos por subescala)
Régimen de acceso	Instrumento comercial distribuido bajo licencia psicométrica (Hogrefe TEA Ediciones / Mind Garden)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)** de Charles D. Spielberger es una de las aportaciones más trascendentales y universales en la historia de la psicometría contemporánea. Su formulación teórica resolvió de manera definitiva la ambigüedad conceptual en torno al constructo de “ansiedad”, estableciendo una clara distinción operativa entre dos facetas psicopatológicas cualitativamente distintas: la **Ansiedad-Estado (A/E)** y la **Ansiedad-Rasgo (A/R)**.

La **Ansiedad-Estado (A/E)** se define como una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, caracterizado por sentimientos subjetivos y conscientemente percibidos de tensión, aprensión, inquietud y por una hiperactivación del sistema nervioso autónomo; fluctúa en el tiempo y responde con gran sensibilidad a situaciones estresantes o intervenciones terapéuticas. Por contraste, la **Ansiedad-Rasgo (A/R)** denota una propensión o disposición ansiosa relativamente estable y duradera de la personalidad, que determina una tendencia habitual a percibir un amplio abanico de situaciones vitales como amenazantes o peligrosas, respondiendo a ellas con elevaciones desproporcionadas en el nivel de estado. La adaptación española de TEA Ediciones consolidó baremos normativos exhaustivos por sexo y edad en centiles y decatipos.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Subescala STAI	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización Psicopatológica
1. Ansiedad Estado (A/E)	20 ítems	0 – 60	Evalúa cómo se siente el sujeto en este momento preciso . Mide tensión, nerviosismo, intranquilidad y activación autonómica (ítems 1 al 20; 10 invertidos).
2. Ansiedad Rasgo (A/R)	20 ítems	0 – 60	Evalúa cómo se siente el sujeto habitualmente / en general . Mide estabilidad emocional, propensión a preocuparse y vulnerabilidad ansiosa (ítems 21 al 40; 7 invertidos).
Puntuación Total STAI	40 ítems	0 – 120	Se interpretan siempre de forma independiente A/E (0-60) y A/R (0-60). Conversión obligatoria a centiles (Pc) y decatipos (DE).

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna A/E	Alpha de Cronbach = 0.90 – 0.93	Sobresaliente consistencia interna en muestras españolas clínicas y de población general (TEA Ediciones).
Consistencia interna A/R	Alpha de Cronbach = 0.84 – 0.88	Alta homogeneidad en la evaluación de la disposición ansiosa constitucional.
Fiabilidad test-retest A/R	r = 0.81 – 0.86 (2 meses)	Excelente estabilidad temporal propia de un rasgo de personalidad estructural.
Fiabilidad test-retest A/E	r = 0.40 – 0.54 (esperable)	Baja estabilidad temporal esperable y metodológicamente adecuada por su naturaleza fluctuante.
Validez convergente	r = 0.75 con MAS (Taylor); r = 0.72 con BAI	Fuerte correlación convergente con la escala de ansiedad manifiesta y el inventario de Beck.
Sensibilidad al estrés y tratamiento	Effect size d = 1.30 en A/E	Elevación reactiva inmediata ante estresores agudos y marcado descenso tras ansiólisis y relajación.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación Likert de 4 anclajes:**
 - Para A/E (ítems 1 al 20): 0 = **Nada**; 1 = **Algo**; 2 = **Bastante**; 3 = **Mucho**. (En la versión clásica de TEA se califica de 0 a 3; en algunos baremos 1 a 4).
 - Para A/R (ítems 21 al 40): 0 = **Casi nunca**; 1 = **A veces**; 2 = **A menudo**; 3 = **Casi siempre**.
- **Ítems Inversos en Ansiedad Estado (A/E) (10 ítems de calma):** Ítems 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20.
 - Se invierte su calificación: **0 = 3 | 1 = 2 | 2 = 1 | 3 = 0**.
- **Ítems Inversos en Ansiedad Rasgo (A/R) (7 ítems de estabilidad):** Ítems 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39.
 - Se invierte su calificación: **0 = 3 | 1 = 2 | 2 = 1 | 3 = 0**.
- **Cómputo Total:** Puntuación directa A/E (0 a 60) y A/R (0 a 60).
- **Transformación Baremos TEA:** Trasladar a **Centil (Pc: 1 a 99)** y **Decatipo (DE: 1 a 10)** según sexo y grupo normativo (general o clínico).

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Centil / Decatipo	Categoría Clínica	Significación Psicopatológica e Indicación Terapéutica
Pc < 50 (Decatipos 1 a 4)	Ansiedad Baja / Normal	Nivel de ansiedad dentro de los márgenes adaptativos habituales. Buena tolerancia al estrés.
Pc 50 – 74 (Decatipos 5 a 6)	Ansiedad Media / Moderada	Nivel de tensión intermedio. Reacciones emocionales comprensibles sin repercusión funcional grave.
Pc 75 – 89 (Decatipos 7 a 8)	Ansiedad Alta	Umbral clínico de alerta. Hiperreactividad fisiológica o aprensión constante. Requiere intervención psicoconductual.
Pc ≥ 90 (Decatipos 9 a 10)	Ansiedad Muy Alta / Extrema	Rango patológico grave. Nivel de sufrimiento elevado y bloqueo funcional. Criterio de caso clínico (TAG, crisis de pánico).

REGLA DE INTERPRETACIÓN DISOCIADA (SPIELBERGER ET AL., 1983): Una discrepancia notable entre ambas subescalas define la etiología clínica: **A/E Alta con A/R Baja** refleja una crisis reactiva situacional aguda (estrés agudo o fobia específica); **A/E Alta con A/R Alta** define un trastorno de ansiedad generalizado o crónico arraigado en la estructura de personalidad.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación y tipificación con baremos españoles TEA:

- Administrar ambas partes por separado. Calcular puntuaciones directas y convertirlas a Centiles según sexo.

Paso 2: Formulación diagnóstica diferencial según el perfil A/E vs. A/R:

- **Perfil 1: A/E $\geq$ Pc 85 y A/R $\leq$ Pc 50 (Ansiedad Situacional Aguda):** Desencadenante estresor claro (quirúrgico, duelo, exámenes). Tratamiento breve enfocado en contención de crisis, técnicas de relajación y benzodiacepinas de forma muy acotada en el tiempo (< 2-4 semanas).
- **Perfil 2: A/E $\geq$ Pc 80 y A/R $\geq$ Pc 80 (Trastorno de Ansiedad Generalizada / Vulnerabilidad Constitucional):** Patrón crónico. Requiere abordaje psicofarmacológico a largo plazo (ISRS como Sertralina o Escitalopram) y psicoterapia cognitivo-conductual centrada en reestructuración de la intolerancia a la incertidumbre.
- **Perfil 3: A/E Normal y A/R Elevada (Vulnerabilidad Latente en Periodo Inter crisis):** Psicoeducación preventiva y entrenamiento en inoculación de estrés.

Paso 3: Monitorización terapéutica con A/E:

- Reaplicar únicamente la subescala A/E en cada sesión para medir el efecto inmediato de la terapia o fármaco.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 42 años, directiva de recursos humanos, remitida por cardiología tras acudir en 3 ocasiones al servicio de urgencias por taquicardias y sensación inminente de infarto con electrocardiogramas normales.

Resultados en el STAI (Baremos Mujeres Adultas Población General):

- **Ansiedad Estado (A/E):** Directa = 46/60 -> Centil 92 (Decatipo 9) -> Muy Alta.
- **Ansiedad Rasgo (A/R):** Directa = 44/60 -> Centil 89 (Decatipo 8) -> Alta.
- Ítems destacados: En A/E refiere “me siento tensa” (3), “estoy atemorizada” (3), “siento que me falta el aire” (3); en A/R refiere “me preocupo demasiado por cosas que no importan” (3) y “las dificultades se me amontonan” (3).

Diagnóstico y Manejo Clínico: La elevación simultánea de A/E y A/R confirmó un Trastorno de Pánico con Agorafobia incipiente sobre una personalidad con elevada vulnerabilidad basal a la ansiedad (neuroticismo). Se inició tratamiento combinado con Sertralina 50 mg/día (aumentada a 100 mg a las 2 semanas) y TCC basada en reatribución interoceptiva y respiración diafragmática. A las 8 semanas de intervención, la subescala A/E descendió a Centil 45 (remisión sintomática completa del estado de alarma), manteniéndose la A/R en Centil 60, con total desaparición de las visitas a urgencias.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD ASISTENCIAL:

- **Descarte médico de etiología orgánica:** En elevaciones bruscas de A/E con taquicardia o temblor, descartar hipertiroidismo, feocromocitoma o arritmias antes de asumir causalidad psicógena.
- **Iatrogenia por benzodiacepinas:** No perpetuar pautas de benzodiacepinas en pacientes con A/R muy alta sin un plan psicoterapéutico de fondo por alto riesgo de adicción.
- **Afectación de la atención:** Puntuaciones A/E extremas deterioran la concentración y el manejo de maquinaria o vehículos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **STAI vs. BDI / Depresión:** Ansiedad y depresión comparten un núcleo de afecto negativo; sin embargo, en el STAI predomina la hiperactivación autonómica frente a la anhedonia y desesperanza depresivas.
- **Deseabilidad social / Fingimiento:** Pacientes en procesos de incapacidad laboral pueden tender a sobredimensionar ítems de A/E; en procesos de selección de personal, la A/R suele mostrar minimización fingida.
- **Acatisia farmacológica:** La inquietud motora por antipsicóticos puede inflar falsamente la A/E.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). **Manual for the State-Trait Anxiety Inventory**. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
2. Seisdedos Cubero, N. (1982, 2002). **STAI: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo, Manual** (7.ª ed.). Madrid: TEA Ediciones.
3. Buéla-Casal, G., Guillén-Riquelme, A., & Seisdedos, N. (2011). **STAI: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo: Adaptación española y nuevas normas**. Madrid: TEA Ediciones.
4. Spielberger, C. D. (1983). **State-Trait Anxiety Inventory for Adults: Sampler Set, Manual, Test, Scoring Key**. Mind Garden. <https://doi.org/10.1037/t06496-000>